



מכת חום

קליניקה ודרכי טיפול בטראומה

שלומית אטלון, בר הוטרר הורוביץ
מלר"ד עין כרם 2024

היפרתרמיה

הגדרה

טמפ' חום גוף מעל 37.5 מעלות. היפרתרמיה חמורה- מעל 40 מעלות.

גורמים

שהייה ארוכה בסביבה חמה, מאמץ גופני, פאוקרומוציטומה, גמילה מאלכוהול, NMS
פרכוס ממושך, אנצפליטיס (פגיעות מוחיות בעלות נזק בהיפותלמוס) סמים ועוד



חום ממקור זיהומי הוא **אינו** היפרתרמיה.

בשתיהן נקבל מדידת חום גבוהה, אך הן פתולוגיות שונות. במטופל הסובל מהיפרתרמיה אין להביא NSAIDs להורדת חום (אין תהליך דלקתי בו התרופה יכולה להתערב. בנוסף לכך הפינוי הכלייתי והכבדי נפגם בשל קריסת מערכות, דבר העלול לגרום להרעלה)

תשישות חום-HEAT EXHAUSTION

מחלה בדרגה בינונית.

מנגנון- דהידרציה+ הזעה מוגברת

קליניקה- בחילות הקאות סחרחורת

טיפול- העברה לסביבה קרה, נוזלים איזוטונים IV\PO,
מנוחה

חום בהכרח לא יעבור את ה40 מעלות, רמת ההכרה תהיה
מלאה\כמעט מלאה

תשישות חום לא מטופלת תהפוך ל- **HEAT STROKE**

מכת חום-HEAT STROKE

מחלה מסכנת חיים

פתופיזיולוגיה- שינויים בזרימת הדם → היפוקסיה ועליה בדרישות מטבוליות →
השפעה ציטוטוקסית של החום → שפעול תגובה דלקתית ומערכת קרישה → קריסה של מערכת
תרמו-רגולציה מלווה בהרס חלבונים. תמותה עד 65%.

תסמינים

- ✓ חום בהכרח גבוה מעל 40
- ✓ עור חם ויבש-ללא הזעה
- ✓ רמת הכרה לא מלאה- ערפול משמעותי\מחוסר הכרה, קליניקה נוירולוגית

הסתמנויות לתופעה

1. EXERTIONAL- מאמץ פיזי במקום חם ולח
2. NON EXERTIONAL- הנפוץ. שהיה ממושכת בסביבה חמה (מעל 39 מעלות)
(ילדים שנשארים ברכב, מאמץ פיזי תחת עומס חום- חיילים ומטיילים)

קליניקה לפי מערכות

◦ **היפרתרמיה+שינויים במצב הכרה**

◦ **מע' CNS** - ערפול הכרה שיהפוך לחוסר הכרה, בצקת מוחית, עליית ICP עד לקומה.

◦ **מע' קרדיוסקולרית** - טכיקרדיה שתהפוך להפרעות קצב בעקבות דנטורציית חלבונים שתפגע בשכבת המיוקארד. שוק היפוולמי מלווה בטכיפנאה



◦ **מע' שריר** - רבדומיליזיס בעקבות פירוק שריר. יגרום לAKI

◦ **מע' קרישה** - חוסר בפקטורי קרישה שיהפוך לDIC

◦ **אסכמיה של איברי הבטן** - בעקבות ניסיון פיצוי של הגוף לקרר את עצמו ע"י הזרמת דם מהליבה אל החיצון- יתבטא באי"ס כליות, כבד, לבלב, היפוגליקמיה

טיפול

טיפול דרסטי בקירור מהיר. המטרה- הגעה לטמפ' ליבה של 39.0 תוך שעה

ABC + הפשטה + מתן 100% חמצן בשל מצב היפר מטבולי
מדידת חום תבוצע PR בלבד 💡



חובה לקרוא
לפנימאי\רפואה דחופה
להערכה וטיפול.

לפי הדיווח ומצבו של
המטופל יש לקרוא
למרדים

קירור פנימי חודרני

✓ עירוי נוזלים קרים

(שקיות FNS קרות במקרר בחדר תרופות
בטראומה)

✓ שטיפת קיבה ע"י הכנסת זונדה
והחדרת מי קרח

✓ שטיפת שלפוחית שתן- בכל
היפרתרמיה יש להכניס **קטטר שתן**
עם מד טמפ' ולחברו למוניטור. דרכו
ניתן לנטר באופן רציף חום ליבה
ולבצע שטיפות במי קרח

קירור חיצוני לא חודרני

✓ מאווררים, מגבות רטובות

✓ שימוש **בשקיות קרח**
המטרה- קירור כלי דם
גדולים: פמורלי, ברכיאלי,
קרוטידי ואת ההיפותלמוס
עצמו.

*לקיחת קרח ממכונת הקרח
בחדר משפחות